O‘zbekiston Respublikasi
Sog‘liqni saqlash vazirligining
2025 yil “____”_____dagi
“_____”-sonli buyrug‘iga
___-ILOVA

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG`LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI
RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN KARDIOLOGIYA ILMIY-AMALIY TIBBIYOT MARKAZI

“INFEKSION ENDOKARDIT” NOZOLOGIYASI BUYICHA MILLIY KLINIK STANDARTLAR

TOSHKENT – 2025

"TASDIQLAYMAN"
O`zbekiston Respublikasi sog`liqni
saqlash vaziri
A.A. Xudayarov
_____
«____»_____2025 y .

“INFEKSION ENDOKARDIT” NOZOLOGIYASI BUYICHA MILLIY KLINIK STANDARTLAR

TOSHKENT – 2025



«KELISHILGAN»
RIKIATM direktori
X.G‘. Fozilov
_____
"____" _____ 2025 yil

“INFEKSION ENDOKARDIT” NOZOLOGIYASI BUYICHA MILLIY KLINIK STANDARTLAR

TOSHKENT 2025

INFEKSION ENDOKARDIT

NOZOLOGIYASI BO‘YICHA TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH MILLIY KLINIK STANDARTI

XKT-10 bo‘yicha kodlanishi:	Nozologik nomlanishi:	Nozologiya bo‘yicha ambulatoriya sharoitida tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar		Nozologiya bo‘yicha statsionar sharoitda tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar	
		Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo‘shimcha jalb etiladigan mutaxassislar	Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo‘shimcha jalb etiladigan mutaxassislar
I33	O‘tkir va surunkali endokardit:	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog
I33.0	O‘tkir va surunkali infeksion endokardit	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog
I33.9	O‘tkir endokardit aniqlanmagan	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog
I38	Endokardit, klapan aniqlanmadi	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg,

					mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog
I39	Endokardit va klapanlarning shikastlanishi boshqa rubrikalarda tasniflangan kasalliklarda:	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog
I39.2	Uch burchak klapanining shikastlanishi boshqa rubrikalarda tasniflangan kasalliklarda	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog
I39.1	Aorta klapanining shikastlanishi boshqa rubrikalarda tasniflangan kasalliklarda	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog
I39.0	Mitral klapanining shikastlanishi boshqa rubrikalarda tasniflangan kasalliklarda	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog
I39.3	Pulmonar arteriya klapanining shikastlanishi boshqa rubrikalarda tasniflangan kasalliklarda	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog

I39.4	Ko‘plab klapanlarning shikastlanishi boshqa rubrikalarda tasniflangan kasalliklarda	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog
I39.8	Endokardit, klapan aniqlanmagan, boshqa rubrikalarda tasniflangan kasalliklarda	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog
T85.7	Boshqa ichki protez qurilmalar, implantlar va transplantatlarga bog‘liq infeksiya va yallig‘lanish reaksiyalari.	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog

XKT-11 bo‘yicha kodlanishi:	**Nozologik nomlanishi:**	**Nozologiya bo‘yicha ambulatoriya sharoitida tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar**		**Nozologiya bo‘yicha statsionar sharoitda tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar**	
		Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo‘shimcha jalb etiladigan mutaxassislar	Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo‘shimcha jalb etiladigan mutaxassislar
BA80	O‘tkir endokardit:	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg,

					mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog
BA80.0	O‘tkir infeksion endokardit	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog
BA80.1	O‘tkir endokardit boshqa bo‘limlarda tasniflangan kasalliklarda	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog
BA80.9	O‘tkir endokardit aniqlanmagan	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog
BA81	Surunkali endokardit	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog
BA81.0	Surunkali infeksion endokardit	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog

BA81.1	Surunkali endokardit boshqa bo‘limlarda tasniflangan kasalliklarda	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog
BA81.9	Surunkali endokardit aniqlanmagan	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog
BA82	Endokardit, yurak klapanlari kasalligi aniqlanmagan	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog
BA82.0	Endokardit, yurak klapanlari kasalligi aniqlanmagan	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog
BA83	Endokardit va yurak klapanlari zararlanishi boshqa bo‘limlarda tasniflangan kasalliklarda	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog

BA83.0	Endokardit boshqa bo‘limlarda tasniflangan kasalliklarda	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog
BA83.1	Mitral klapan zararlanishi boshqa bo‘limlarda tasniflangan kasalliklarda	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog
BA83.2	Aorta klapani zararlanishi boshqa bo‘limlarda tasniflangan kasalliklarda	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog
BA83.3	Trikuspidal klapan zararlanishi boshqa bo‘limlarda tasniflangan kasalliklarda	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog
BA83.4	O‘pka arteriyasining klapani zararlanishi boshqa bo‘limlarda tasniflangan kasalliklarda	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog

AB75.6	Kandidoz endokarditi	VOP/Terapevt/Kardiolog	Revmatolog, Infeksionist, klinik farmakolog, LOR	Kardiolog/ kardioxirurg /reanimatolog/	Revmatolog, Infeksionist, Intervension aritmolog Ftiziatr, endokrinolog, pulmonolog, LOR, oftalmolog, gematolog, toksikolog, neyroxirurg, mikrobiolog, nevropatolog, nefrolog klinik farmakolog

***standartni to‘ldirish jarayonida nozologiya, uning kattalar, xomiladorlar, bolalar va qariyalarda kechuvi hamda nozologiya bo‘yicha kasallikni davri xususiyatidan kelib chiqish talab etiladi.**

Shuningdek, nozologiya ga to‘g‘ri kelmaydigan jadvallarni to‘ldirish tavsiya qilinmaydi. (Misol uchun, jarroxlik amaliyoti nozologiyasida o‘tkazilmasa (JARROHLIK AMALIYOTI) jadvali to‘ldirilmaydi yoki nozologiyada palliativ davo ko‘zda tutilmasa – (PALLIATIV DAVO) jadvali to‘ldirilmaydi.

DIAGNOSTIKA, DAVOLASh, REABILITATSIYa va DISPANSERIZATSIYa TADBIRLARI

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Tibbiy yordam ko‘rsatish darajasi va turi bo‘yicha					Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi Ambulator yordam
		Ambulator yordam		Statsionarnaya pomoщ				
		OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Asosiy mutaxassis (shifokor) maslahati	1. Semeynыy vrach	+					O‘tkir asoratlanmagan endokarditdan keyin oyiga bir marta 3 oy davomida	Ambulator kuzatuv o‘tkir endokarditda 3 oy, surunkali endokarditda SYuYe bilan bo‘lsa - umrbod; Statsionar davolanish: 10-12 kun*
	2. Kardiolog		+	+	+	+	- o‘tkir asoratlanmagan endokarditdan keyin 1 marta - 3 oy davomida har oyda bir marta o‘tkir asoratlangan endokarditdan keyin - SYuYe I-II FS bilan surunkali endokardit uchun: yiliga 2 marta; - SYuYe III-IV FS bilan surunkali endokardit uchun yiliga 4 marta	
	3. Terapevt		+	+				
Izoh: * statsionar sharoitidagi davolanish muddati bo‘lgan gospitalizatsiya maqsadiga bog‘liq. Statsionar sharoitidagi mutaxassis ko‘riklari har kungi bo‘ladi.								
Mutaxassis	1. revmatolog			+	+	+	Ko‘rsatmaga	

(shifokor) maslahati (qo‘shimcha)	2. infeksionist				+	+	binoan	
	3. Intervension aritmolog					+		
	4. ftiziatr		+	+	+	+		
	5. endokrinolog		+	+	+	+		
	6. pulmonolog			+	+	+		
	7. lor		+	+	+	+		
	8. oftalmolog		+	+	+	+		
	9. gematolog			+	+	+		
	10. toksikolog			+	+	+		
	11. neyroxirurg			+	+	+		
	12. mikrobiolog			+	+	+		
	13. nevropatolog		+	+	+	+		
	14. nefrolog		+	+	+	+		
	15. klinik farmakolog			+	+	+		
Izoh: Barcha tor mutaxassislar ko‘rigi ko‘rsatmaga binoan tashkillashtiriladi. Statsionar sharoitada tor mutaxassislarning ko‘rik soni klinik holatiga muvofiq tashkillashtirilishi lozim.								
Asosiy laborator tekshiruvlar	1. Umumiy qon tahlili	+	+	+	+	+	- o‘tkir asoratlanmagan endokarditdan keyin 1 marta - 3 oy davomida har oyda bir marta o‘tkir asoratlangan endokarditdan keyin - SYuYe I-II FS bilan surunkali endokardit uchun: yiliga 2 marta; - SYuYe III-IV FS bilan surunkali endokardit uchun yiliga 4 marta	
	2. Umumiy siydik tahlili							
	3. ALT, AST, bilirubin							
	4. Glyukoza	+	+	+	+	+		
	5. Kreatinin	+	+	+	+	+		
	6. Mochevina	+	+	+	+	+		
	7. S-reaktiv oksil	+	+	+	+	+		
	8. Revmatoid faktor		+	+	+	+		

	9. Antistreptolizin-O		+	+	+	+		
	10. Qon gemokulturaga ekmasi			+	+	+		
Izoh: agar OShP/OP moddiy-texnik bazasi o‘tkir fazali sinamalarni (SRO, ASLO, RF) tekshirish imkoyanitiga ega bo‘lsa, oilaviy shifokor tomonidan bu tekshiruvlar bajarilishi lozim. Statsionar sharoitida laborator tekshiruvlarning soni klinik holatdan kelib chiqqan tarzda aniqlanadi.								
Qo‘shimcha laborator tekshiruvlar	1. Koagulogramma, AChTV		+	+	+	+	Ko‘rsatmaga binoan	
	2. Obщiy belok			+	+	+		
	3. Albumin			+	+	+		
	4. Globulinы (α-, β-, γ-fraksii)			+	+	+		
	5. Obщiy bilirubin			+	+	+		
	6. Prokalsitonin			+	+	+		
	7. VICh			+	+	+		
	8. gepatit B va C			+	+	+		
	9. Vasserman Reaksiyasi (RW)			+	+	+		
	10. Kaliy			+	+	+		
	11. Natriy			+	+	+		
	12. Troponin			+	+	+		
	13. D-dimer				+	+		
	14. Mozgovoy natriyureticheskiy peptid			+	+	+		
	1. . Guruh va qon rezus omili hamda antieritrotsitar antitelalar		+	+	+	+		
	2. Gemokultura tahlili PSR usuli bilan			+	+	+		
	3. Yurak klapanlaridan (protezlarlardan) ekmalari			+	+	+		
Izoh: Qon guruhi, gepatit V va S, OIV ga tekshiruvlar jarrohlik amaliyotlar rejalashtirilgan bemorlar uchun bajarilishi lozim. Statsionar sharoitida laborator tekshiruvlarning soni klinik holatdan kelib chiqqan tarzda aniqlanadi.								
Asosiy instrumental tekshiruvlar	1. EKG	+	+	+	+	+	- o‘tkir asoratlanmagan endokarditdan	

							keyin 1 marta - 3 oy davomida har oyda bir marta o‘tkir asoratlangan endokarditdan keyin - SYuYe I-II FS bilan surunkali endokardit uchun: yiliga 2 marta; - SYuYe III-IV FS bilan surunkali endokardit uchun yiliga 4 marta	
	2. Transtorakal ExoKG			+	+	+		
	3. Transezofageal ExoKG				+	+		
	4. Yurakning MSKT				+	+		
Izoh: Statsionar sharoitida EKGni soni klinik holatdan kelib chiqqan tarzda aniqlanadi.								
Qo‘shimcha instrumental tekshiruvlar	1. ExoKG		+	+	+	+	Ko‘rsatmaga binoan	
	2. Ko‘krak qafasi rentgenografiyasi		+	+	+	+		
	3. Xolter bo‘yicha EKG ni monitorlash				+	+		
	4. Invaziv koronarografiya				+	+		
	5. EFI				+	+		
	6. Ichki a’zolar UTT		+	+	+	+		
	7. MRT serdsa s kontrastirovaniem				+	+		
	8. Patomorfologicheskie issledovaniya klapanov (protezov) serdsa				+	+		
	9. Intralyuminal (intravaskulyar) yurak ichi ExoKG				+	+		
	10. Yurak kateterizatsiyasi				+	+		
Izoh: Statsionar sharoitida instrumental tekshiruvlarning soni klinik holatdan kelib chiqqan tarzda aniqlanadi								

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Tibbiy yordam ko‘rsatish darajasi va turi bo‘yicha					Xizmat ko‘rsatish yoki tekshiruvni o‘tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
		OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	1. CHA2DS2-VASc va HAS-BLED shkalalari	+	+	+	+	+	Har ko‘rikda	
Izoh: Endokardit va bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi bo‘lgan bemorlar ishemik insult xavfini baholash uchun CHA2DS2-VASc shkalasi qo‘llaniladi. Endokardit va bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi bo‘lgan bemorlar oral antikoagulyantlar qo‘llanilganda qon ketish ehtimolligini baholash uchun HAS-BLED shkalasi qo‘llaniladi.								

(MEDIKAMENTOZ TERAPIYa)

Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davo)		REJALI tibbiy yordam ko‘rsatish darajasi va turi bo‘yicha					O‘rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo‘llanilishi	OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxona-lari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Ro‘yxat asosida qarshi-mikrobli dorilarni qo‘llash ehtimoli 100% bo‘lgan: A) Penitsillinlar: - Benzilpenitsillin natriy tuzi - Ampitsillin B) sefalosporinlar: - sefazolin V) b-laktamalar - Amoksitsillin/klavulanat G) Sulfonamidlar - Ko-trimoksazol	Benzilpenitsillina natrievaya sol 250 000-500 000 YeD kajdыe 6 chasov;; Sutochnuyu dozu delyat na 4-6 vvedeniy.			+	+	+	sutkalik doza 1.000.000-2.000.000 YeD maksimalnaya – 40.000.000-60.000.000 YeD v sutki vnutrivenno	klinik holatiga bog‘liq
	Ampitsillin 2 g vnutrivenno kajdыe 4 chasa.			+	+	+	Maksimalnaya doza: 12 g/den	kamida 4-8 hafta
	Sefazolin ot 1 do 1,5 g v / v kajdыe 6 chasov ili 2 g v / v			+	+	+	Maksimalnaya doza: 12 g/den	kamida 4-6 hafta

	kajdыe 8 chasov							
	Amoksitsillin / klavulanat V zavisimosti ot stepeni tyajesti infeksii, naznachayut 1000 mg/100 mg kajdыe 8 chasov ili 2000/200 mg			+	+	+		
	Ko-trimoksazol ➢ Sulfometoksazol 4 800 mg/den ➢ Trimetoprim 960 mg/den (v/v v 4-6 vvedeniy)			+	+	+		
Infeksion endokarditni antibakterial davolash, Streptococcus spp. tomonidan chaqirilgan. 1. Penitsillinga sezgir shtammlar (MIK<0,125 mg/l) og'iz bo'shlig'i va ovqat hazm qilish tizimi streptokokkllari	Benzilpenitsillin - 12-18 mln. 4-6 vvedeniy YeD, v/v;			+	+	+		Davolashning standart sxemasi, 4 hafta davom etadi. Protez klapanlari zararlanganda, davolash muddati - 6 hafta.
	Amoksitsillin-100-200 mg/kg/sut, v/v 4-6 vvedeniy;			+	+	+		
	Seftriakson 2 g/sut, v/v ili v/m v 1 vvedenie			+	+	+		
	[2]Benzilpenitsillin - 12-18 mln. YeD, v/v, 4-6 vvedeniy; ili			+	+	+		Davolashning standart sxemasi, 2 hafta
	[2]Amoksitsillin- 100-200 mg/kg/sut, v/v, 4-6 vvedeniy; ili			+	+	+		
	[2]Seftriakson + Gentamitsin2 g/sut, v/v ili v/m v 1 vvedenie +3 mg/kg/sut, v/v ili v/m v 1 vvedenie»			+	+	+		

	ili							
	[2]Netilmitsin 4-5 mg/kg/sut, v/v v 1 vvedenie;			+	+	+		
Beta-laktamlarga allergiyasi bo‘lgan bemorlarda	Vankomitsin - 30 mg/kg/sut, v/v v 2 vvedeniya;			+	+	+		4 hafta Pri porajenii protezirovannыx klapanov - dlitelnost do 6 hafta.
1. Penitsillinga nisbatan chidamli shtammlar (MPK 0,250-2 mg/l)	[3]Benzilpenitsillin- 500 000 YeD kajdыe 6 chasov; ili			+	+	+	sutkalik doza 2 000 000 YeD; maksimalnaya – 40 000 000-60 000 000 YeD v sutki v/v	4 hafta (nativ klapan) 6 hafta i > (protezirlangan klapan)
	Amoksitsillin- 100-200 mg/kg/sut, v/v v 4-6 vvedeniya.			+	+	+	Maksimal doza: 12 g/kun	
	[4]Seftriakson 2 g/sut, v/v ili v/m kajыe 12-24 chasa v techenii 4-6 hafta. Plyus			+	+	+		
	[5]Gentamitsin 3 mg/kg/sut, v/v ili v/m v 1 vvedenie.			+	+	+		
Beta-laktamlarga allergiyasi bo‘lgan bemorlarda	Vankomitsin - 30 mg/kg/sut, v/v, v 2 vvedeniya			+	+	+		4 hafta (nativnыy klapan) 6 hafta i > (protezirovannыy klapan)
1. Stafilokokklar bilan bog‘liq infeksion endokarditni antibakterial davolash A) tabiiy klapanlar	(Flu)kloksatsillin ili oksatsillin 12 g/sut, v/v v 4-6 vvedeniy; ili			+	+	+		Davolash muddati 4-6 hafta.
	Ko-trimaksozol. Sulfametoksazol 4800 mg/sut i Trimetoprim 960 mg/sut (v/v, 4-6			+	+	+		Davolash muddati: 1 v/v +5 per os

	vvedeniy) 1800 mg/sut v 3 vvedeniya. plyus							
	Klindamitsin 1800 mg/den v 3 vvedeniya.			+	+	+		Davolash muddati: 1 hafta.
Penitsillinga yoki metitsillinga sezgir stafilokokklarga allergiyasi bo‘lgan bemorlar.	Vankomitsin 30-60 mg/kg/sut, v/v v 2-3 vvedeniya ili			+	+	+		Davolash muddati 4-6 hafta.
	Daptomitsin10 mg/kg/sut, v/v v 1 vvedenie ili			+	+	+		
	Ko-trimaksozol + Klindamitsin Sulfametoksazol 4800 mg/sut i Trimetoprim 960 mg/sut (v/v, 4-6 vvedeniy) 1800			+	+	+		Davolash muddati 1 v/v+ 5 per os mg/sut v 3 vvedeniya.
				+	+	+		
				+	+	+		
B) protez qilingan klapanlar Metitsillinga sezgir stafilokokk shtammlari	Oksatsillin 12 g/sut v/v v 4-6 vvedeniy; + Rifampitsin 900-1200 mg/sut, v/v ili vnutr v 2-3 vvedeniya; +			+	+	+		Davolash muddati ≥6 hafta.
	Gentamitsin 3 mg/kg/sut, v/v ili v/m v 1 vvedenie;			+	+	+		Davolash muddati 2 hafta

Beta-laktamlarga allergiyasi bo‘lgan bemorlar, metitsillinga sezgir stafilokokk shtammlari.	**Vankomitsin 30-60 mg/kg/sut, v/v v 2-3 vvedeniya; + Rifampitsin 900-1200 mg/sut, v/v v 2-3 vvedeniya; +**			**+**	**+**	**+**		**Davolash muddati ≥6 hafta**
	Gentamitsin 3 mg/kg/sut, v/v ili v/m v 1 vvedenie;			**+**	**+**	**+**		**Davolash muddati 2 hafta**
2. Enterokokklar tomonidan chaqirilgan infeksion endokarditni antibakterial davolash Beta-laktamlarga va gentamitsinga sezgir shtammla	**[6]Amoksitsillin 200 mg/kg/sut, v/v v 4-6 vvedeniy; +**			**+**	**+**	**+**		**Davolash muddati 4-6 hafta**
	[6]Gentamitsin 3 mg/kg/sut, v/v ili v/m v 1 vvedenie;			**+**	**+**	**+**		**Davolash muddati 2-6 hafta**
	[7]Ampitsillin 200 mg/kg/sut, v/v v 4-6 vvedeniy; + Seftriakson 4 g, v/v ili v/m v 2 vvedeniya; ili			**+**	**+**	**+**		**Davolash muddati -6 hafta**
	[8]Vankomitsin 30 mg/kg/sut, v/v v 2 vvedeniya + Gentamitsin 3 mg/kg/sut, v/v ili v/m v 1 vvedenie;			**+**	**+**	**+**		
3. Glyukokortikosteroidы[4]: - Prednizolon	**Prednizolon 30-40 mg v sutki**		**+**	**+**	**+**	**+**	**Prednizolon 30-40 mg v sutki**	**3-6 oy**

4. Blokatorlar RAAS: **A) iAPF:** **- Enalapril** **- Ramipril** **- Perindopril** **B) BRA (sartanlar):** **- Valsartan** **- Lozartan** **- Kandesartan** **- Telmisartan** **- Azilsartan** **- Olmesartan**	**iAPF:** **- Enalapril 2,5-20 mg 2 raz v den** **- Ramipril 2,5-10 mg 1 raz v den** **- Perindopril erbumin 2-8 mg 1 raz v den** **- Perindopil arginin 2,5-10 mg 1 raz v den** **BRA:** **- Valsartan – 40-320 mg 2 raz v den** **- Lozartan 25-100 mg 1 raz v de** **- Kandesartan 4-32 mg 1 raz v den** **- Telmisartan 10-80 mg 1 raz v den** **- Azilsartan 20-80 mg 1 raz v den** **- Olmesartan 10-40 mg 1 raz v den**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**iAPF:** **- Enalapril 2,5-20 mg** **- Ramipril 2,5-10 mg** **- Perindopril erbumin 2-8 mg** **- Perindopil arginin 2,5-10 mg** **BRA:** **- Valsartan – 40-320 mg** **- Lozartan 25-100 mg** **- Kandesartan 4-32 mg** **- Telmisartan 10-80 mg** **- Azilsartan 20-80 mg** **- Olmesartan 10-40 mg**	**Davolash muddati klinik holatiga bog‘liq**
5. ARNI[5]: **- Sakubitril/Valsartan**	**24/26 mg (50 mg), 49/51 mg (100 mg) ili 97/103 mg (200 mg). Po 1 tabletke 2 raza v den (doza podbiraetsya pod kontrolem AD)**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**100-400 mg**	**Davolash muddati klinik holatiga bog‘liq**
6. Beta-blokatorlar: **- Bisoprolol** **- Metoprolol** **- Nebivalol** **- Karvedilol**	**- Bisoprolol 2,5-10 mg 1 raz v den** **- Metoprolol suksinat 25-100 mg 1 raz v den** **- Nebivalol 2,5-10 mg 1 raz v den** **- Karvedilol 3,125-25 mg kunlik dozasi 2-3 raza v**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**- Bisoprolol 2,5-10 mg** **- Metoprolol suksinat 25-100 mg** **- Nebivalol 2,5-10 mg** **- Karvedilol 3,125-**	**Davolash muddati klinik holatiga bog‘liq**

	den						**25 mg**	
7. Antagonistlar mineralokortikoidnых retseptorlarni: **- Spironolakton** **- Eplerenon**	**- Spironolakton 25-50 mg po 1 tabl. (kaps) 1 raz v den;** **- Eplerenon 25-50 mg po 1 tabl. 1 raz v den.**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**- Spironolakton 25-50 mg** **- Eplerenon 25-50 mg**	**Davolash muddati klinik holatiga bog‘liq**
8. SGLT2-ingibitorы: **- Empagliflozin** **- Dapagliflozin**	**- Empagliflozin 10-25 mg po 1 tabl. 1 raz v den;** **- Dapagliflozin 10 mg po 1 tabl. 1 raz v den.**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**- Empagliflozin 10-25 mg po 1 tabl. 1 raz v den;** **- Dapagliflozin 10 mg po 1 tabl. 1 raz v den.**	**Davolash muddati klinik holatiga bog‘liq**

Izoh:

Asosiy guruhdagi qarshi-mikrobli preparatlar empirik tarzda yoki aniqlangan qo‘zg‘atuvchiga qarab yakka tartibda yoki kombinatsiya shaklida qo‘llaniladi.

Qo‘shimcha dori vositalari ham mavjud bo‘lib, ular asosiy ro‘yxatdagi preparatlar bilan birga qo‘llanadi (qo‘llash ehtimoli 100% dan kamroq).

1. 65 yoshdan oshgan bemorlarda, buyrak kasalliklari va bosh miya asablarining VIII juftligi shikastlanganida afzal ko‘riladi.

2. Asoratlanmagan endokardit va normal buyrak funksiyasiga ega bemorlarga tavsiya etiladi.

3. 65 yoshdan oshgan bemorlarda va buyrak faoliyati buzilishi yoki VIII (vestibulo-koxlear) asabi faoliyati buzilishlarida afzal hisoblanadi.

4. Davolanish davomida periferik qon manzarasini, jigar va buyrak holatini nazorat qilish kerak.

5. Gentamitsin dozasi qon zardobidagi maksimal konsentratsiyaga erishish uchun tanlanadi.

6. Simptomlar 3 oydan ortiq saqlanib qolganda yoki protez qilingan klapanlar shikastlanganda davolanish 6 haftagacha davom ettiriladi.

7. E. faecalis ga nisbatan faollik.

8. E. faecalis ga nisbatan faol emas.

Statsionar darajasida olingan tavsiyalarga asoslanib, ambulator darajadagi davolashni uzviyligini ta’minlash maqsadida boshqa antibiotiklar ham qo‘llanilishi mumkin, ular yuqorida ko‘rsatilmagan.

Beta-blokatorlar, RAAT blokatorlari (AAFi yoki sartanlar), MKRA va SGLT2-ingibitorlari endokarditning nospesifik terapiyasi deb hisoblanadi va barcha bemorlarga buyurilishi mumkin

Davolash tadbirlari (qo‘shimcha medikamentoz davo)		**REJALI tibbiy yordam ko‘rsatish darajasi va turi bo‘yicha**					**O‘rtacha sutkalik dozirovkasi**	**Bir kurslik dozirovka**
		Ambulator yordam		**Statsionar yordam**				
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	**Dori-vositaning dozirovkasi va qo‘llanilishi**	**OShP/OP**	**KTMP**	**Tuman (shahar) shifoxonalari**	**Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari**	**Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari**		

1. Oral antikoagulyantlar[1]: **- Rivaroksaban** **- Apiksaban**	**- Rivaroksaban 15-20 mg 1 mahal** **- Apiksaban 2,5-5 mg 2 mahal**		**+**	**+**	**+**	**+**	**- Rivaroksaban 15-20 mg 1 mahal** **- Apiksaban 2,5-5 mg 2 mahal**	
2. Bevosita antikoagulyantlar: **- Geparin** **- Enoksiparin**	**- Geparin 5000 TB t/o 4 mahal;** **- Enoksiparin 100 antiXa TB bemorni 1 kg vazniga nisbatan 2 mahal**			**+**	**+**	**+**	**- Geparin 5000 TB t/o 4 mahal;** **- Enoksiparin 100 antiXa TB bemorni 1 kg vazniga nisbatan 2 mahal**	
3. Antiaritmiklar: **- Amiodaron** **-Allapinin** **- Propafenon** **- Etatsizin** **- Verapamil** **- Diltiazem**	**- Amiodaron 200 mg to‘yindirsh sxemasi bo‘yicha;** **- Allapinin 25 mg 1 tabl. mahal;** **- Propafenon 150 mg 1 tabl. 3 mahal;** **- Etatsizin 50 mg 1 tabl. 3 mahal;** **- Verapamil 80-160 mg 1 tabal. 2-3 mahal;** **- Diltiazem 90 mg 1 tabl. 2 mahal**		**+**	**+**	**+**	**+**	**- Amiodaron 200 mg to‘yindirsh sxemasi bo‘yicha;** **- Allapinin 25 mg 1 tabl. mahal;** **- Propafenon 150 mg 1 tabl. 3 mahal;** **- Etatsizin 50 mg 1 tabl. 3 mahal;** **- Verapamil 80-160 mg 1 tabal. 2-3 mahal;** **- Diltiazem 90 mg 1 tabl. 2 mahal**	**Terapiya muddati klinik holatiga bog‘liq**
4. Ivabradin	**5-7,5 mg 1 tabl. 2 mahal**		**+**	**+**	**+**	**+**	**10-15 mg**	
5. Trimetazidin	**80 mg 1 marta sutkasiga, 35 mg 2 marta sutkasiga**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**70-80 mg**	
6. Ranolazin	**500-1000 mg 2 marta sutkasiga**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**1000-2000 mg**	
7. Halqa diuretiklar:	**- Furosemid 40 mg 1**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**- Furosemid 40**	

- Furosemid - Torasemid	tabl. 1 mahal; - Torasemid 10 mg 1 tabl. 1 mahal						mg 1 tabl. 1 mahal; - Torasemid 10 mg 1 tabl. 1 mahal	
Izoh: [1]Endokardit bilan og‘rigan bemorlarda BF borligida oral antikoagulyantlari buyuriladi.								

Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davo)		ShOShILINCh tibbiy yordam ko‘rsatish darajasi va turi bo‘yicha					O‘rtacha sutkalik dozirovkasi KTMP	Bir kurslik dozirovka Tuman (shahar) shifoxonalari Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo‘llanilishi	OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	LPU na urovne oblasti Dori-vositaning dozirovkasi va qo‘llanilishi	OShP/OP		

Ro‘yxat asosida qarshi-mikrobli dorilarni qo‘llash ehtimoli 100% bo‘lgan: A) Penitsillinы: - Benzilpenitsillina natrievaya sol ampitsillin B) sefalosporinы: - sefazolin V) b-laktamы Amoksitsillin / klavulanat G) sulfanilamidы Ko-trimoksazol	Benzilpenitsillina natrievaya sol 250 000-500 000 YeD kajdыe 6 chasov;; Sutochnuyu dozu delyat na 4-6 vvedeniy.			+	+	+	sutkalik doza 1.000.000-2.000.000 YeD maksimalnaya – 40.000.000-60.000.000 YeD v sutki vnutrivenno	kamida 4-8 hafta
	Ampitsillin 2 g vnutrivenno kajdыe 4 chasa. Sefazolin ot 1 do 1,5 g v / v kajdыe 6 chasov ili 2 g v / v kajdыe 8 chasov			+	+	+	Maksimalnaya doza: 12 g/den Maksimalnaya doza: 12 g/den	kamida 4-8 hafta
	Amoksitsillin / klavulanat V zavisimosti ot stepeni tyajesti infeksii, naznachayut 1000 mg/100 mg kajdыe 8 chasov ili 2000/200 mg			+	+	+		
	Ko-trimoksazol ➢ Sulfometoksazol 4 800 mg/den ➢ Trimetoprim 960 mg/den (v/v v 4-6 vvedeniy)			+	+	+		
1. Glyukokortikosteroidы[2]: - Prednizolon	Prednizolon 30-40 mg v sutki		+	+	+	+	Prednizolon 30-40 mg v sutki	3-6 mesyasev
2. Blokatorы RAAS: A) iAPF: - Enalapril - Ramipril - Perindopril B) BRA (sartanlar): - Valsartan	iAPF: - Enalapril 2,5-20 mg 2 raz v den - Ramipril 2,5-10 mg 1 raz v den - Perindopril erbumin 2-8 mg 1 raz v den	+	+	+	+	+	iAPF: - Enalapril 2,5-20 mg - Ramipril 2,5-10 mg - Perindopril erbumin 2-8 mg	Dlitelnost terapii klinik holatiga bog‘liq

- Lozartan - Kandesartan - Telmisartan - Azilsartan - Olmesartan	- Perindopil arginin 2,5-10 mg 1 raz v den BRA: - Valsartan – 40-320 mg 2 raz v den - Lozartan 25-100 mg 1 raz v de - Kandesartan 4-32 mg 1 raz v den - Telmisartan 10-80 mg 1 raz v den - Azilsartan 20-80 mg 1 raz v den - Olmesartan 10-40 mg 1 raz v den						- Perindopil arginin 2,5-10 mg BRA: - Valsartan – 40-320 mg - Lozartan 25-100 mg - Kandesartan 4-32 mg - Telmisartan 10-80 mg - Azilsartan 20-80 mg - Olmesartan 10-40 mg	
3. ARNI[3]: - Sakubitril/Valsartan	24/26 mg (50 mg), 49/51 mg (100 mg) ili 97/103 mg (200 mg). Po 1 tabletke 2 raza v den (doza podbiraetsya pod kontrolem AD)	+	+	+	+	+	100-400 mg	Dlitelnost terapii klinik holatiga bog‘liq
4. Beta-blokatorы: - Bisoprolol - Metoprolol - Nebivalol - Karvedilol	- Bisoprolol 2,5-10 mg 1 raz v den - Metoprolol suksinat 25-100 mg 1 raz v den - Nebivalol 2,5-10 mg 1 raz v den - Karvedilol 3,125-25 mg kunlik dozasi 2-3 raza v den	+	+	+	+	+	- Bisoprolol 2,5-10 mg - Metoprolol suksinat 25-100 mg - Nebivalol 2,5-10 mg - Karvedilol 3,125-25 mg	Dlitelnost terapii klinik holatiga bog‘liq
5. Antogonistы mineralokortikoidnыx retseptorov: - Spironolakton - Eplerenon	- Spironolakton 25-50 mg po 1 tabl. (kaps) 1 raz v den; - Eplerenon 25-50 mg po 1 tabl. 1 raz v den.	+	+	+	+	+	- Spironolak-ton 25-50 mg - Eplerenon 25-50 mg	Dlitelnost terapii klinik holatiga bog‘liq
6. SGLT2-ingibitorы:	- Empagliflozin 10-25 mg	+	+	+	+	+	- Empagliflozin	Dlitelnost terapii

- Empagliflozin - Dapagliflozin	po 1 tabl. 1 raz v den; - Dapagliflozin 10 mg po 1 tabl. 1 raz v den.						10-25 mg po 1 tabl. 1 raz v den; - Dapagliflozin 10 mg po 1 tabl. 1 raz v den.	klinik holatiga bog‘liq

Izoh:

[2] Glyukokortikosteroidlar uchun ko‘rsatma: autoimmun kasalliklar bilan bog‘liq endokardit.

[3] ARNI ChQ OF past (<40%) bo‘lgan endokarditli bemorlarda RAAT blokatorlariga qaraganda afzalroq.

Beta-blokatorlar, RAAT blokatorlari (AAFi yoki sartanlar), MKRA va SGLT2-ingibitorlari endokarditning nospesifik terapiyasi deb hisoblanadi va barcha bemorlarga buyurilishi mumkin.

Davolash tadbirlari (qo‘shimcha medikamentoz davo)		ShOShILINCh tibbiy yordam ko‘rsatish darajasi va turi bo‘yicha					O‘rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo‘llanilishi	OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
1. Oral antikoagulyantlar[1]: - Rivaroksaban - Apiksaban	- Rivaroksaban 15-20 mg 1 mahal - Apiksaban 2,5-5 mg 2 mahal		+	+	+	+	- Rivaroksaban 15-20 mg 1 mahal - Apiksaban 2,5-5 mg 2 mahal	Terapiya muddati klinik holatiga bog‘liq
2. Bevosita antikoagulyantlar: - Geparin - Enoksiparin	- Geparin 5000 TB t/o 4 mahal; - Enoksiparin 100 antiXa TB bemorni 1 kg vazniga nisbatan 2 mahal			+	+	+	- Geparin 5000 TB t/o 4 mahal; - Enoksiparin 100 antiXa TB bemorni 1 kg vazniga nisbatan 2 mahal	
3. Antiaritmiklar: - Amiodaron - Verapamil - ATF - Lidokain - Esmolol	- Amiodaron 5%-3 ml v/i; - Verapamil 0,25%-2 ml v/i - ATF 1%-1 ml v/i - Lidokain 1%-2 ml		+	+	+	+	- Amiodaron 5%-3 ml v/i; - Verapamil 0,25%-2 ml v/i - ATF 1%-1 ml v/i	

- Atropin	v/i - Esmolol 1%-1 ml v/i - Atropin 0,1%-1 ml t/o, v/i						- Lidokain 1%-2 ml v/i - Esmolol 1%-1 ml v/i - Atropin 0,1%-1 ml t/o, v/i	
4. Ivabradin	5-7,5 mg 1 tabl. 2 mahal			+	+	+	10-15 mg	
5. Trimetazidin	80 mg 1 marta sutkasiga, 35 mg 2 marta sutkasiga			+	+	+	70-80 mg	
6. Ranolazin	500-1000 mg 2 marta sutkasiga			+	+	+	1000-2000 mg	
7. Halqa diuretiklar: - Furosemid - Torasemid	- Furosemid 1%-2 ml v/i; - Torasemid 2,5%-4 ml v/i	+	+	+	+	+	- Furosemid 1%-2 ml v/i; - Torasemid 2,5%-4 ml v/i	
8. Vazopressorlar: - Dobutamin - Dopamin - Noradrenalin	- Dobutamin 2,5-10 mkg/kg/daq v/i; - Dopamin 1-20 mkg/kg/daq v/i; - Noradrenalin 0,05-0,3 mkg/kg/daq v/i			+	+	+	- Dobutamin 2,5-10 mkg/kg/daq v/i; - Dopamin 1-20 mkg/kg/daq v/i; - Noradrena-lin 0,05-0,3 mkg/kg/daq v/i	
Izoh: [1]Endokardit bilan og‘rigan bemorlarda BF borligida oral antikoagulyantlari buyuriladi.								

(OPERATIV DAVO)

Davolash tadbirlari (operativ davo)	REJALI/ShOShILINCh tibbiy yordam ko‘rsatish darajasi va turi bo‘yicha				
	Ambulator yordam		Statsionar yordam		
Jarrohlik amaliyoti/aralashuv/muolaja nomi	OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari

1. Yurak bo‘shliqlarini sanatsiyasi					
2. Yurak klapanlarini rekonstruksiya qilish					
3. Protezlash yoki qayta protezlash (biologik, mexanik) klapanlarni o‘rnatish					
4. Vaqtinchali/Doimiy EKS o‘rnatish					
5. IKD o‘rnatish				+	+
6. CRT uskunasini o‘rnatish				+	+
7. Radiochastotali ablatsiya				+	+
8. Aorta ichi ballonli kontrpulsatsiyasi				+	+
Izoh: Jarrohlik aralashuvlarga bo‘lgan ko‘rsatmalar ko‘p toifali konsilium qarori asosida aniqlanishi kerak.					

(PARHEZ)

Ovqatlanish tartibi	Tibbiy yordam ko‘rsatish darajasi va turi bo‘yicha				
	Ambulator yordam		Statsionar yordam		
Parhez stoli va uning davomiyligi	OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari
1. 10-sonli stol umrbod	+	+	+	+	+

(DISPANSERIZATSIYa)

Dispanserizatsiya tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	OShP/OP	KTMP	Tadbirlar minimal soni	Dispanser nazorati muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	1. Hamshira	+	+	- o‘tkir asoratlanmagan endokarditdan keyin 1 marta - 3 oy davomida har oyda bir marta o‘tkir asoratlangan endokarditdan keyin - SYuYe I-II FS bilan	Ambulator kuzatuv o‘tkir endokarditda 3 oy, surunkali endokarditda SYuYe bilan bo‘lsa - umrbod
	2. Oilaviy shifokor	+			
	3. Kardiolog		+		
	4. Terapevt		+		
	5. Revmatolog		+		
	6. LOR		+		

				surunkali endokardit uchun: yiliga 2 marta; - SYuYe III-IV FS bilan surunkali endokardit uchun yiliga 4 marta	
Izoh: Yurak-qon tomir tizimining faoliyatini nazorat qilish uchun takroriy tekshiruvlar tavsiya etiladi.					
Laborator tekshiruvlar	**1. Umumiy qon tahlili**	**+**	**+**	**- o‘tkir asoratlanmagan endokarditdan keyin 1 marta - 3 oy davomida har oyda bir marta o‘tkir asoratlangan endokarditdan keyin - SYuYe I-II FS bilan surunkali endokardit uchun: yiliga 2 marta; - SYuYe III-IV FS bilan surunkali endokardit uchun yiliga 4 marta**	
	2. Umumiy siydik tahlili	**+**	**+**		
	3. SRO	**+**	**+**		
	4. Qondagi kreatinin	**+**	**+**		
	5. ASLO	**+**	**+**		
	6. ALT, AST, bilirubin	**+**	**+**		
	7. Koagulogramma	**+**	**+**		
	8. Troponin		**+**		
	9. RF		**+**		
Izoh: Davriy ko‘riklarda ko‘rsatmaga muvofiq qo‘shimcha laborator tekshiruvlar tavsiya qilinadi.					
Instrumental tekshiruvlar	**1. EKG**	**+**	**+**	**- o‘tkir asoratlanmagan endokarditdan keyin 1 marta - 3 oy davomida har oyda bir marta o‘tkir asoratlangan endokarditdan keyin - SYuYe I-II FS bilan surunkali endokardit uchun: yiliga 2 marta; - SYuYe III-IV FS bilan surunkali endokardit uchun yiliga 4 marta**	
	2. EXOKG		**+**	**Ko‘rsatmaga muvofiq**	

	3. XMEKG		**+**		
	4. Ko‘krak qafasi rentgenoskopiyasi		**+**		
Izoh: Davriy ko‘riklarda ko‘rsatmaga muvofiq qo‘shimcha instrumental tekshiruvlar tavsiya qilinadi.					